Poder Judiciário
Tribunal de Justiça do Estado do Rio Grande do Sul
Vara Estadual da Saúde Pública

Rua Manoelito de Ornelas, 50 - Bairro: Praia de Belas - CEP: 90110230 - Fone: (51) 3210-6500 - Email: frpoacentvesp@tjrs.jus.br

PROCEDIMENTO COMUM CÍVEL Nº 5014268-21.2025.8.21.0039/RS

AUTOR: DIENIFER IRIGARAY SILVEIRA

RÉU: IPE-SAÚDE - INSTITUTO DE ASSISTÊNCIA À SAÚDE DOS SERVIDORES PÚBLICOS DO RIO GRANDE DO SUL

SENTENÇA

DIENIFER IRIGARAY SILVEIRA ajuizou ação ordinária em face do IPE-SAÚDE alegando possuir diagnóstico de **neoplasia de ovário metastático (CID10-C56)** e que, em razão disso, necessita fazer uso do medicamento **Trastuzumabe Deruxtecana**. Requereu a procedência da demanda, a fim de que seja fornecida a medicação postulada (evento 1, INIC1).

Deferida a tutela de urgência, bem como a gratuidade da justiça (evento 27, DESPADEC1).

O IPE-SAÚDE informou a autorização administrativa para o tratamento com o fármaco postulado (evento 41, OFIC1).

Citado, o réu contestou, alegando, em síntese, que não pode admitir, nem ser compelido à cobertura de um tratamento que excede o previsto por seu regulamento, de custo elevado, sob pena de ser levado à insolvência, prejudicando a coletividade associada. Requereu a improcedência da ação (evento 36, CONT1).

A parte autora apresentou réplica (evento 45, RÉPLICA1).

Instadas as partes sobre eventual interesse na dilação probatória (evento 48, DESPADEC1), nada requereram (evento 53, PET1; evento 55, PET1).

O Ministério Público opinou pela procedência da demanda (evento 58, PROMOÇÃO1).

É o relatório.

Passo a fundamentar.

I. DO MÉRITO

I.1. Do Direito à Saúde

Destaca-se, de início, que a Constituição Federal, em seu art. 5º, *caput*, ao tratar dos direitos e garantias fundamentais da pessoa, garantiu o direito à vida e em seu art. 6º, *caput*, que cuida dos direitos sociais, assegurou o direito à saúde, dentre outros. Não bastasse isso, o art. 196, que trata da ordem social, prescreveu o direito à saúde de forma circunstanciada.

A Constituição Estadual do Rio Grande do Sul, no mesmo sentido, em seu art. 241, preceitua que a saúde é um direito de todos.

I.2. Da necessidade do tratamento

No caso em análise, a tutela de urgência foi deferida, a qual abaixo colaciono e passo a ratificar (evento 27, DESPADEC1):

> *Vejamos, observa-se que o IPE-SAÚDE não fornece o medicamento postulado.*
>
> *Por cautela, considerando a complexidade da prestação de saúde postulada, o Juízo requisitou a emissão de parecer, que retornou com a seguinte resposta:*
>
> *Tecnologia: TRASTUZUMABE DERUXTECANA*
>
> *Conclusão Justificada: Favorável*
>
> *Conclusão: Considerando o diagnóstico de neoplasia ovariana metastática com progressão de doença após múltiplos esquemas de quimioterapia; Considerando, segundo informações da equipe assistente, tratar-se de neoplasia com expressão HER2; Considerando os achados do estudo DESTINY-PanTumor02 cuja taxa de resposta ao trastuzumabe deruxtecana no tratamento de câncer de ovário (N=15) foi de 66,7%; Considerando que o anticorpo conjugado a droga trastuzumabe deruxtecana (T-Dxd) recebeu da ANVISA (Agência Nacional de Vigilância Sanitária), em 25 de novembro de 2024, a aprovação para o tratamento de pacientes adultos com tumores sólidos HER-2 positivos (imunohistoquímica 3+) irressecáveis ou metastáticos que já receberam tratamento sistêmico anterior e não possuem boas opções de tratamento disponíveis;Conclui-se que há subsídios para embasar o uso da medicação pleiteada no caso em tela. Observação: Esta indicação foi aprovada com base em resultados de eficácia de Fase 2 com desfecho primário de taxa de resposta geral. A manutenção da aprovação para esta indicação, depende da verificação e descrição do benefício clínico nos estudos confirmatórios.*
>
> *Há evidências científicas? Sim*

Justifica-se a alegação de urgência, conforme definição de Urgência e Emergência do CFM? Sim

Justificativa: Com risco de lesão de órgão ou comprometimento de função

Diante das alegações médicas, entendo que, em não sendo realizado o tratamento postulado, devido a impedimentos de ordem administrativa, a parte autora teria prejudicada de forma considerável a possibilidade de tratamento de sua enfermidade com consequente prejuízo a sua saúde.

Vale dizer, restando comprovado que a parte autora necessita submeter-se a tratamento utilizando o medicamento postulado, não há razão para a negativa do IPERGS, a quem incumbe assegurar o tratamento e a intervenção mais adequados para o trato da sua enfermidade. Importante aduzir, ainda, que a parte autora mantém contrato firmado com o Instituto, contribuindo para o referido plano de saúde, o qual deve lhe garantir acesso amplo e seguro à assistência à saúde.

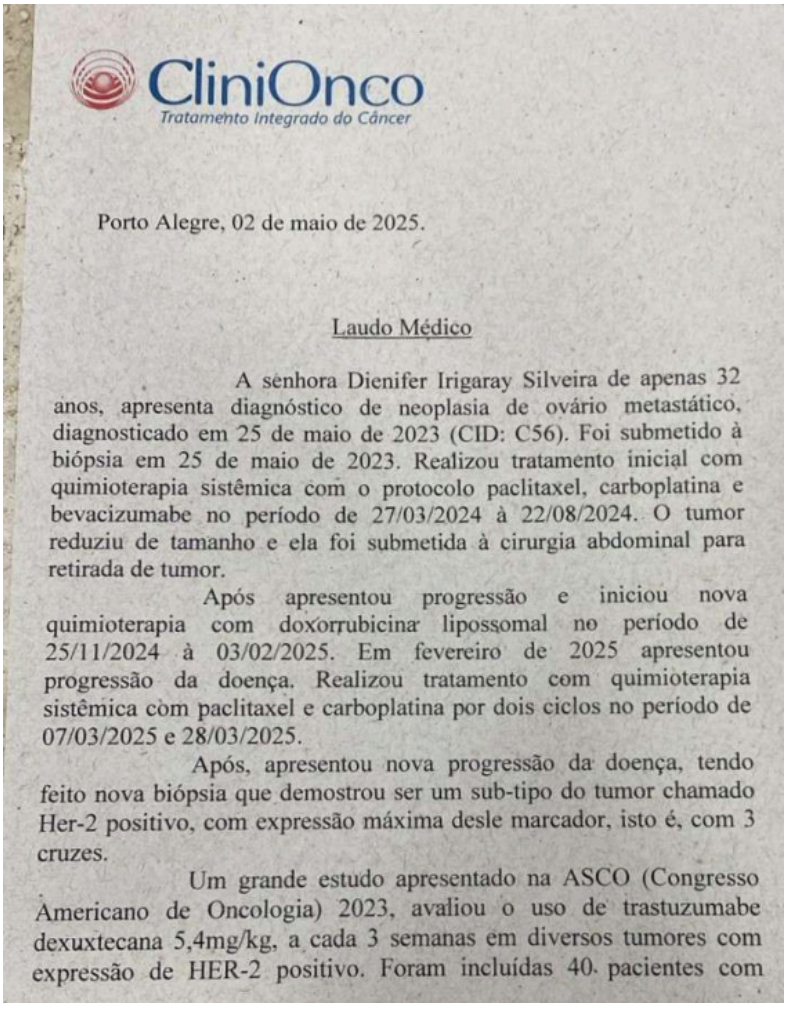
Por fim, em que pese este juízo não desconheça que em 06.04.2018, entrou em vigor a Lei Complementar n.° 15.145/2018, que dispõe sobre a reestruturação do Sistema de Assistência à Saúde dos Servidores Públicos do Rio Grande do Sul – Sistema IPE Saúde, revogando a Lei Complementar n.º 12.134/2004 e excluindo da cobertura do IPE Saúde os procedimentos, exames, tratamentos, insumos, materiais, que não estejam previstos nas tabelas próprias do Instituto (art. 4º, § 1º), é pacífica a jurisprudência do Superior Tribunal de Justiça no sentido de que cabe ao plano de saúde prever as enfermidades as quais será fornecida a cobertura de tratamento, entretanto, não é facultado ao plano escolher quais tratamento serão dispensados. Neste sentido:

*AGRAVO INTERNO NO AGRAVO EM RECURSO ESPECIAL. AÇÃO DE OBRIGAÇÃO DE FAZER CUMULADA COM DANOS MATERIAIS. PLANO DE SAÚDE. RECUSA DE TRATAMENTO A DOENÇA COBERTA. ÍNDOLE ABUSIVA. ASTREINTES. AUSÊNCIA DE PREQUESTIONAMENTO, AINDA QUE IMPLÍCITO. AGRAVO INTERNO NÃO PROVIDO. 1. Conforme entendimento consolidado nesta Corte, é possível o reconhecimento de prequestionamento implícito, para fins de conhecimento do recurso especial, quando as questões debatidas no recurso especial tenham sido decididas no acórdão recorrido, ainda que sem a explícita indicação dos dispositivos de lei que o fundamentaram. In casu, a questão atinente ao valor atribuído na origem às astreintes não foi debatida nem decidida no acórdão de origem, não tendo sido prequestionado o art. 461, § 6º, do CPC/73. Incidência das Súmulas 282 e 356/STF. 2. A jurisprudência desta Corte reconhece a possibilidade de o plano de saúde estabelecer as doenças que terão cobertura, mas não o tipo de tratamento utilizado, sendo abusiva a negativa de cobertura do procedimento, tratamento, **medicamento** ou material considerado essencial para sua realização de acordo com o proposto pelo médico (AgInt no AREsp 949.765/SP, Rel. Ministro MOURA RIBEIRO, TERCEIRA TURMA, julgado em 1º/12/2016, DJe de 19/12/2016). 3. Agravo interno não provido.*

Assim, assegurado o direito da parte autora em ter a sua saúde resguardada, e comprovada a necessidade que possui em receber o tratamento pleiteado, tenho, em cognição sumária, que é caso de deferimento da tutela pretendida.

*Ante o exposto, **DEFIRO O PEDIDO DE ANTECIPAÇÃO DE TUTELA** formulado e determino ao **IPE-Saúde** que, no prazo de 05 (cinco) dias úteis, passe a disponibilizar à parte autora o medicamento **Trastuzumabe Deruxtecana,** nos termos da prescrição e laudo médicos, os quais deverão ser atualizados pela parte autora semestralmente.*

A necessidade resta evidenciada pela documentação médica acostada aos autos (evento 1, LAUDO7; evento 6, LAUDO2), que indica possuir a parte autora diagnóstico de **neoplasia de ovário metastático (CID10-C56)** e que, em razão disso, é imprescindível o uso do medicamento **Trastuzumabe Deruxtecana**. Da mesma forma, comprovada a urgência do tratamento, salientando o laudo médico que o uso mais breve possível da medicação evitará a progressão para obstrução intestinal completa, a necessidade de procedimentos invasivos adicionais, o prolongamento do sofrimento físico e psicológico e o risco de óbito precoce. Senão vejamos:



ClinOnco
Tratamento Integrado do Câncer

Porto Alegre, 02 de maio de 2025.

Laudo Médico

A senhora Dienifer Irigaray Silveira de apenas 32 anos, apresenta diagnóstico de neoplasia de ovário metastático, diagnosticado em 25 de maio de 2023 (CID: C56). Foi submetido à biópsia em 25 de maio de 2023. Realizou tratamento inicial com quimioterapia sistêmica com o protocolo paclitaxel, carboplatina e bevacizumabe no período de 27/03/2024 à 22/08/2024. O tumor reduziu de tamanho e ela foi submetida à cirurgia abdominal para retirada de tumor.

Após apresentou progressão e iniciou nova quimioterapia com doxorrubicina lipossomal no período de 25/11/2024 à 03/02/2025. Em fevereiro de 2025 apresentou progressão da doença. Realizou tratamento com quimioterapia sistêmica com paclitaxel e carboplatina por dois ciclos no período de 07/03/2025 e 28/03/2025.

Após, apresentou nova progressão da doença, tendo feito nova biópsia que demostrou ser um sub-tipo do tumor chamado Her-2 positivo, com expressão máxima desle marcador, isto é, com 3 cruzes.

Um grande estudo apresentado na ASCO (Congresso Americano de Oncologia) 2023, avaliou o uso de trastuzumabe dexuxtecana 5,4mg/kg, a cada 3 semanas em diversos tumores com expressão de HER-2 positivo. Foram incluídas 40 pacientes com

câncer de ovário politratadas. A duração de resposta em 12 semanas foi de 70%. A taxa de resposta de pacientes com HER-2 3 cruzes, foi de 63,6. Essa medicação foi aprovada para esta indicação pelo FDA ((Food and Drug Administration) (J Clin Oncol 42:47,2024).

A sobrevida livre de progressão é superior há 1 ano. Nenhum outro agente de quimioterapia tem esta resposta, (J Clin Oncol 2023 , Oct 23;42; 47-58).

O trastuzmabe deruxtecan (Enhertu) é um anticorpo monoclonal dirigido particularente a este marcador Her-2, funcionando como uma medicação teleguiada ao tumor, sendo altamente específica.

Esta medicação já foi aprovado em câncer de mama em 2023.

Em novembro de 2024, a Anvisa aprovou o Enhertu para qualquer tipo de câncer apresentado o marcador Her-2.

A dose da medicação é 5,4mg/kg, a cada 3 semanas, por, pelo menos, 1 ano.

Recentemente, a paciente teve de ser novamente operada devido à oclusão intestinal por tumor, na Santa Casa. A paciente está tendo alta hoje, e tem uma oportunidade de iniciar, esta nova medicação. Obviamente, é um caso de urgência urgentíssima, pois é uma oportunidade fugaz.

Atenciosamente,

Dr. Jeferson Vinholes
Oncologista
CRM 18 CPF: 488.482.200-53
Dr. Jeferson Vinholes

LAUDO MÉDICO DE URGÊNCIA

Data: 25/05/2025
Paciente: Dienifer Irigaray Silveira
Data de Nascimento: 14/01/1993 (32 anos)
Registro Hospitalar: 451142
Instituição: Hospital Pavilhão Pereira Filho - Santa Casa de Porto Alegre

DESTINATÁRIO: EXCELENTÍSSIMO(A) SENHOR(A) JUIZ(A) DE DIREITO

RELATÓRIO MÉDICO PARA FINS JUDICIAIS - CARÁTER DE EXTREMA URGÊNCIA

Eu, Dr. Luciano Muller Correa da Silva, CRM-RS 21970, Pneumologista, venho por meio deste apresentar o quadro clínico atual da paciente supracitada, internada sob meus cuidados desde 11/05/2025, com diagnóstico de câncer de ovário mucinoso em estágio avançado com carcinomatose peritoneal progressiva (CID10 C56).

HISTÓRICO CLÍNICO RESUMIDO

A paciente, de apenas 32 anos, foi submetida a múltiplos procedimentos cirúrgicos oncológicos, incluindo histerectomia total ampliada, salpingooforectomia esquerda, peritoniectomia pélvica e omentectomia infracólica. Apesar das intervenções cirúrgicas agressivas, a doença apresenta progressão acelerada, documentada por exames de imagem seriados.

QUADRO CLÍNICO ATUAL - SITUAÇÃO DE EMERGÊNCIA MÉDICA

A tomografia computadorizada realizada em 24/05/2025 (ontem) evidencia inequívoca progressão da carcinomatose peritoneal, caracterizada por:

Aumento significativo das áreas de espessamento peritoneal e infiltração dos planos adiposos peritoneais

Alças intestinais aderidas à parede abdominal com alternância de segmentos distendidos e estreitados, configurando quadro de obstrução intestinal parcial em progressão
Surgimento de derrame pleural bilateral
Novas coleções líquidas no mesogástrio e flanco direito

Clinicamente, a paciente apresenta:

Dificuldade progressiva de ingesta alimentar
Náuseas e vômitos persistentes
Anemia (hemoglobina 8,7 g/dL)
Dor abdominal de difícil controle
Comprometimento nutricional progressivo

PROGNÓSTICO E URGÊNCIA TERAPÊUTICA

O quadro atual configura EMERGÊNCIA ONCOLÓGICA com risco iminente de:

Obstrução intestinal completa, condição que exigiria intervenção cirúrgica de alto risco em paciente já debilitada, com elevada morbimortalidade
Desnutrição grave por impossibilidade de alimentação adequada
Insuficiência respiratória pelo derrame pleural em progressão
Deterioração rápida do estado geral com risco de óbito a curto prazo

NECESSIDADE IMPERIOSA DE TRATAMENTO QUIMIOTERÁPICO

A quimioterapia representa, neste momento, a ÚNICA ALTERNATIVA TERAPÊUTICA com potencial de:

Reduzir a carga tumoral peritoneal
Restabelecer o trânsito intestinal
Aliviar o sofrimento físico intenso da paciente
Oferecer possibilidade de sobrevida com qualidade

A AUSÊNCIA OU ATRASO no início da quimioterapia resultará, com elevado grau de certeza médica, em:

Progressão para obstrução intestinal completa
Necessidade de procedimentos invasivos adicionais
Prolongamento do sofrimento físico e psicológico
Risco substancialmente aumentado de óbito precoce

CONCLUSÃO E SOLICITAÇÃO

Atesto, com base em minha experiência profissional e nos achados objetivos documentados, que a paciente Dienifer Irigaray Silveira encontra-se em SITUAÇÃO DE EXTREMA GRAVIDADE E URGÊNCIA MÉDICA, necessitando IMEDIATAMENTE do início da terapia quimioterápica prescrita.

O atraso na liberação deste tratamento, por qualquer motivo, configura risco real e iminente à vida da paciente, além de prolongar um sofrimento que poderia ser mitigado com a terapêutica adequada.

Coloco-me à disposição deste Juízo para quaisquer esclarecimentos adicionais que se façam necessários, inclusive por contato telefônico direto (51) 997013378 / 999129554.

Respeitosamente,

Dr. Luciano Muller Correa da Silva
CRM-RS 21970
Pneumologista
Hospital Pavilhão Pereira Filho - Santa Casa de Porto Alegre

CID

C56 - Neoplasia maligna do ovário

***MEMED** - Acesso à sua receita digital via QR Code* **Data e hora:** *25/05/2025 - 14:34:27* (GMT-3)
Endereço: Independencia
*Assinado digitalmente por **Luciano Muller Correa da Silva - CRM 21970 RS***
*Token (Farmácia): **hXL6OK** - Código de desbloqueio (Paciente): **3146***

Com efeito, o(a) médico(a) assistente é quem detém a melhor capacidade para indicar os medicamentos com melhor eficácia para o tratamento da parte autora.

A assistência à saúde prestada pelo IPE-Saúde está submetida ao regime de direito público e deve seguir as regras definidas na Lei Complementar nº 15.145/2018 e os atos normativos da autarquia estadual, o que afasta a aplicabilidade do Código de Defesa do Consumidor no caso concreto.

Em 06.04.2018, entrou em vigor a Lei Complementar nº 15.145/2018, que dispõe sobre a reestruturação do Sistema de Assistência à Saúde dos Servidores Públicos do Rio Grande do Sul – Sistema IPE-Saúde, revogando a Lei Complementar nº 12.134/2004 e excluindo da cobertura do IPE-Saúde os procedimentos, exames, tratamentos, insumos, materiais e medicamentos que não estejam previstos nas tabelas próprias do Instituto (art. 4º, § 1º).

Destarte, comprovado que a parte autora necessita submeter-se ao tratamento preconizado pelo(a) médico(a) assistente, não há razão para a negativa do IPE-Saúde, a quem incumbe assegurar o tratamento e a intervenção mais adequados para o trato da sua enfermidade. Para tanto, seria necessário que o Instituto requerido expusesse de forma clara e específica a justificativa técnica médica para o indeferimento do tratamento postulado.

Importante aduzir que a parte autora mantém contrato firmado com o Instituto, contribuindo para o referido plano de saúde, o qual deve lhe garantir acesso amplo e seguro à assistência à saúde.

Logo, considerando a gravidade da enfermidade que acomete a parte autora, não se mostra minimamente razoável limitar as alternativas terapêuticas disponíveis para o seu tratamento às listadas em protocolo que historicamente não consegue acompanhar a velocidade dos avanços da medicina, o que, caso ocorresse, configuraria efetiva negativa de adequado tratamento à parte autora, expondo-a a risco de dano irreparável a sua saúde.

Ademais, descabida a alegação do demandado de que o fornecimento da prestação de saúde, por não estar previsto nas suas tabelas vigentes à época, implicaria sobrecarga ou mesmo comprometimento do orçamento da autarquia destinado à saúde, porquanto eventual negativa, nessas circunstâncias, só poderia ocorrer com base em contestação técnica médica suficiente.

Não há prova alguma no processo que evidencie qualquer impedimento ao cumprimento da determinação judicial pelo demandado. Outrossim, a autarquia não se desincumbiu de provar que o tratamento indicado pelo médico assistente acarretaria oneração desnecessária para o Instituto.

Com efeito, em que pese a medicação solicitada não constasse nas tabelas de cobertura da autarquia, não há que se falar em ilegalidade da pretensão da parte autora, tampouco em afronta aos princípios da isonomia e da igualdade. Neste sentido:

> *APELAÇÃO CÍVEL. IPE-SAÚDE. PACIENTE COM DIAGNÓSTICO DE NEOPLASIA DE COLO UTERINO (CID 10 C53).* ***NEGATIVA DE COBERTURA ADMINISTRATIVA PARA FORNECIMENTO DE MEDICAMENTO CALCADA NA AUSÊNCIA DE PREVISÃO CONTRATUAL. EXEGESE DO ART. 4º DA LEI COMPLEMENTAR N.º 15.145/2018. SUFICIÊNCIA DO LAUDO MÉDICO. VIOLAÇÃO AOS PRINCÍPIOS DA LEGALIDADE E ISONOMIA. INOCORRÊNCIA.*** *MINORAÇÃO DOS HONORÁRIOS ADVOCATÍCIOS. DESCABIMENTO. 1. Conforme preconiza o artigo 4º da Lei Complementar n.º 15.145/2018, aplicável ao caso em análise, o Plano IPE-SAÚDE é integrado pelos atendimentos médicos, hospitalares, envolvendo os atos necessários ao diagnóstico e ao tratamento, bem como ações de prevenção da doença e à promoção da saúde. Inegável, assim, a responsabilidade de custeio integral do fármaco ora postulado. 2.* ***A escolha do medicamento e do tipo de tratamento a ser concedido ao paciente cabe ao médico e não ao convênio, já que somente o profissional especializado é quem poderá optar e recomendar qual o melhor método e/ou material a ser utilizado em cada caso, tudo no objetivo de alcançar o melhor resultado.*** *3. Não merece guarida o apelo do IPE Saúde quanto à pretensão de redução da verba honorária sucumbencial. Com efeito, os honorários de sucumbência fixados em favor do patrono da parte autora observaram*

os parâmetros razoáveis, estando em conformidade com o disposto no art. 85, §§2º e 8º, do CPC/15. APELAÇÃO DESPROVIDA. (Apelação Cível, Nº 50004065020158210130, Segunda Câmara Cível, Tribunal de Justiça do RS, Relator: Ricardo Torres Hermann, Julgado em: 25-05-2022) [grifos nossos].

Dessa maneira, evidenciado o direito ao fornecimento do(s) medicamento(s) postulado(s) ao tratamento de sua patologia, imperioso o julgamento procedente da ação.

Diante do exposto, **JULGO PROCEDENTES** os pedidos formulados por DIENIFER IRIGARAY SILVEIRA em face do IPE-SAÚDE, tornando definitiva a decisão que deferiu a tutela de urgência, determinando o fornecimento do medicamento **Trastuzumabe Deruxtecana,** na dosagem e periodicidade determinadas pelo médico assistente, e por tempo indeterminado.

Isento o demandado do pagamento da **Taxa Única de Serviços Judiciais**, consoante o previsto no artigo 5º, inciso I, da Lei nº 14.634/14.

Condeno o demandado ao pagamento das **despesas processuais NÃO ABRANGIDAS PELA TAXA ÚNICA** (artigos 14 e seguintes da Lei nº 14.634/2014, e artigo 84 do CPC), bem como ao pagamento de **honorários sucumbenciais** ao(à) procurador(a) da parte autora, que fixo em R$ 2.000,00, nos termos do artigo 85, §8º, do CPC.

Em conformidade ao artigo 3º da Emenda Constitucional nº 113/2021, o valor dos honorários deverá ser atualizado monetariamente pela Taxa Selic a contar da data da sua fixação; com incidência de juros moratórios, segundo o mesmo índice da Taxa Selic, a contar do trânsito em julgado, conforme artigo 85, §16, do CPC.

Sentença registrada e publicada eletronicamente, da qual vão as partes intimadas via sistema Eproc.

Interposta apelação, processe-se, conforme os trâmites legais e, após, remetam-se os autos ao Tribunal de Justiça.

Havendo saldo vinculado ao feito, expeça-se alvará a quem de direito.

Após o trânsito em julgado, certifique-se e procedam-se com os **atos ordinários necessários** à cobrança de eventuais despesas processuais: expedição de RPV, intimações, alvarás para destinação dos valores e demais atos.

Consigno que, após o trânsito em julgado da sentença, nos termos do Ofício-Circular nº 077/2019-CGJ, o cumprimento de sentença deverá tramitar com novo número de processo no Eproc, incumbindo ao exequente distribuí-lo em autos apartados, vinculando o número do processo de conhecimento e recolhendo as custas correspondentes, se for o caso.

Por fim, baixe-se.

Documento assinado eletronicamente por **HERACLITO JOSE DE OLIVEIRA BRITO, Juiz de Direito**, em 18/07/2025, às 17:42:58, conforme art. 1º, III, "b", da Lei 11.419/2006. A autenticidade do documento pode ser conferida no site https://eproc1g.tjrs.jus.br/eproc/externo_controlador.php?acao=consulta_autenticidade_documentos, informando o código verificador **10086902247v6** e o código CRC **8ccb2f39**.